

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

تقييم المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية لدى أطفال

ذوي اضطراب طيف التوحد (من 03 إلى 06 سنوات)

Evaluation of verbal and non-verbal communication skills in autism spectrum disorder children (between 03 and 06 years old)

مخاطي حليلة Mekhati halima¹، يعلاوي خليدة Yaalaoui khalida²

¹ طالبة دكتوراه، جامعة علي لونيبي-البليدة 02، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،

قسم العلوم الاجتماعية، مخبر اللغة والمعرفة والتفاعل

PHD student, Ali lounissi-blida2 University, College of social and human, Departement of social sciences, Language Knowledge and Interaction Laboratory

Ch.mekhati@univ-blida2.dz

² أستاذة تعليم عالي، جامعة علي لونيبي-البليدة 02، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.

قسم العلوم الاجتماعية، مخبر اللغة والمعرفة والتفاعل

Professor, Ali lounissi-blida2 University, College of social and human, Departement of social sciences, Language Knowledge and Interaction Laboratory

dr.yaalaoui@gmail.com

Ch.mekhati@univ-blida2.dz

المؤلف المراسل: مخاطي حليلة Mekhati halima

تاريخ القبول: 2024/12/31

تاريخ الاستلام: 2024/10/10

الملخص:

تهدف الدراسة الحالية الى تقييم مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي عند الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، حيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية وتكونت هذه الأخيرة من عشرة (10) أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تراوحت أعمارهم ما بين 03 و06 سنوات، لديهم درجة متوسطة من الاضطراب، شخوصا من خلال مقياس تقدير التوحد الطفولي (CARS)، وطبقنا عليهم مقياس تقييم المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية عند الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد للباحثة ابتسام الحسني (2020)، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي لتفسير المعطيات، وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا، توصلت الدراسة الى النتائج التالية : الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد يعانون من صعوبات على مستوى المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية، و كذلك توصلت الدراسة إلى أن مستوى المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتميز بانخفاض في كل أبعاد المقياس .
الكلمات المفتاحية: مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، اضطراب طيف التوحد، التقييم.

Abstract:

The current study aimed to evaluate the verbal and non-verbal communication skills of children with autism spectrum disorder. The sample was selected intentionally and consisted of ten (10) children with autism spectrum disorder, aged between 03 and 06 years, with a moderate degree of disorder, diagnosed through the Childhood Autism Rating Scale (CARS). We applied the verbal and non-verbal communication skills assessment scale for children with autism spectrum disorder by researcher Ibtisam Al-Hasani (2020). The descriptive approach was adopted to interpret the data. After collecting and statistically processing the data, the study reached the following results: Children with autism spectrum disorder suffer from difficulties in verbal and non-verbal communication skills. The study also found that the level of verbal and non-verbal communication skills of children with autism spectrum disorder is characterized by a decrease in all five dimensions of the scale.

Keywords: Evaluation; verbal and nonverbal communication skills; Autism Spectrum Disorder.

مقدمة:

إن اضطراب طيف التوحد يعتبر من الاضطرابات المعقدة والغامضة، الذي يظهر في السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، وتشير الدراسات الحديثة أن هذا الاضطراب ينتج عن اضطرابات عصبية تؤثر في وظائف الدماغ، حيث تظهر عند الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد مشاكل وصعوبات في جوانب كثيرة منها: التفاعل الاجتماعي، التواصل اللفظي و غير اللفظي ونشاطات اللعب والتخيل، كما تظهر هذه الفئة حركات نمطية متكررة وكذلك تريد لكلمات غير مفهومة ومقاطع بشكل آلي وليس لها علاقة بسياق الموقف، كما أنهم لديهم مقاومة شديدة للتغيير في البيئة المحيطة بهم، ونلاحظ عليهم بصفة خاصة التعلق بالأشياء أكثر من التعلق بالأشخاص.

إن اضطراب طيف التوحد يعرف انتشارا واسعا في العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم تشخيص فرد من بين 68 شخص بما يعرف باسم اضطراب طيف التوحد Autism Spectrum Disorder (ASD) وذلك بحسب مركز منع الامراض والوقاية منها (Center For Disease Control and Prevalence-CDC-2014) ويمثل هذا الرقم زيادة في الانتشار بشكل عام خلال العقدين الماضيين، ففي عام 1990 كانت الارقام تشير الى ان نسبة الانتشار كانت (5-10) من بين (10.000) فرداً¹.

أما في الجزائر فلا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المصابين باضطراب طيف التوحد و نسبة زيادة إنتشاره، وذلك لعدم وجود إحصائيات لهذه الفئة صادرة عن جهة مختصة تقوم بإحصاء وتتبع تطور وانتشار اضطراب طيف التوحد على المستوى الوطني، لكن حسب تصريحات العاملين في الميدان مع هذه الفئة من أطباء الطب العقلي للأطفال والمختصين النفسيين العياديين والأخصائيين الأطوفونيين فإن عدد الحالات التي يستقبلونها في تزايد مستمر كل عام.

إن ملامح طفل طيف التوحد الجسدية لا تنبئ عن وجود هذا الاضطراب، كما أن أسبابه غير محددة وواضحة، كما أن الإنتشار الواسع لهذا الاضطراب الذي يمس جميع بلدان العالم دون استثناء عرقي، اجتماعي، اقتصادي أو ثقافي...، وحتى أساليب العلاج متداخلة بين الطب العقلي للأطفال وعلم النفس العيادي والأرطوفونيا وعلوم التربية، كما يعتبر

مجال طيف التوحد واسع وغني بالمتغيرات التي تثير اهتمام الباحثين في مجالات مختلفة، وهذا ما يجعل ميدان البحث عن هذا الاضطراب خصب للباحثين، ومن أهم ما يميز طفل طيف التوحد الاضطرابات على مستوى التواصل، حيث تصب الدراسة الحالية في هذا المجال والتي جاءت للوقوف على أهم مشكل يعاني منه أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ألا وهي التواصل بشقيه اللفظي وغير لفظي.

يؤثر اضطراب التوحد بشكل كبير على مهارات التواصل والتي لها دور فعال في ربط الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمحيطه، إذ أن مهارات التواصل هي تلك الوسائل والاستراتيجيات والتقنيات التي يكتسبها الفرد لتمكنه من التفاعل مع الآخرين و مشاركتهم في الأنشطة اليومية المختلفة والمتنوعة، كما تزيد هذه المهارات من قدرة الفرد على التعبير والحركة بفعالية، وتضم المهارات التواصلية نوعين من المهارات هما: المهارات التواصلية اللفظية (التقليد اللفظي، الفهم، التعبير...)، والمهارات التواصلية غير اللفظية (الإيماءات وتعبيرات الوجه، التواصل البصري، التقليد الحركي، الإنتباه والإهتمام المشترك...)، ويظهر ذلك خاصة فيما يتعلق بمواقف اللعب والاحتكاك مع الآخرين.

إن اضطراب المهارات التواصلية من الخصائص المميزة والأساسية التي يعاني منها الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، وهذه الخصائص يعتمد عليها الأخصائيون في تشخيص اضطراب طيف التوحد، و تضم مجموعة من الاضطرابات التواصلية اللفظية والغير لفظية والتي تتفاوت في شدتها وتختلف في شكلها وتتغير من حالة إلى أخرى.

إن اضطراب المهارات التواصلية عند طفل ذو اضطراب طيف التوحد يؤدي إلى مشكلات متعددة تظهر جليا على سلوك الطفل، مثل: الصراخ، التخريب، العدوانية، الإحتجاج، إذاء الذات، النشاط الحركي المفرط...، وتعتبر هذه المشكلات إنعكاش لفشل الطفل الذين يعاني من اضطراب طيف التوحد في التواصل مع محيطه وعدم قدرته على التعبير عن إحتياجاته ومشاعره بشكل مفهوم من الآخرين، كما يعجز عن توصيل الرسالة التي يردها إلى محيطه لأنه ليس لديه القدرة على ذلك.

ولأهمية مهارات التواصل بالنسبة لطفل طيف التوحد في التفاهم وتبادل المعلومات مع محيطه والتعبير عن أفكاره وبت مشاعره وأحاسيسه، أدى بالأخصائيين إلى دراسة وتقييم

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارة التقليد.

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارة الفهم.

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارة التعبير.

إن الدراسة الحالية رمت إلى تحقيق الأهداف التالية:

-تقدير وتقييم مستوى مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي عند الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

-التعرف على خصائص المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية عند الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

-التعرف على الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية.

تتجلى أهمية الدراسة الحالية في كونها تعالج موضوع مهم في مجال طيف التوحد، وخاصة مضطربة ومميزة لهم ويعتمد عليها الاختصاصيين في تشخيص هذا الاضطراب وهي مهارات التواصل، حيث تجلت هذه الأهمية فيما يلي:

الأهمية النظرية:

تساهم هذه الدراسة على المستوى في إثراء أدبيات مجال اضطراب طيف التوحد وذلك بالتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي عند الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد التي تعتبر عامل وعرض مهم في تشخيص هذا الاضطراب.

كيفية تقييم هذه المهارات لدى هذه الفئة، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى هذه المهارات.

الأهمية التطبيقية:

تساعد هذه الدراسة على المستوى التطبيقي الاختصاصيين في هذا المجال في التعرف على مهارات التواصل ومستواها عند أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وهذا يعتبر الأساس المهم لبناء البرامج العلاجية والتأهيلية والتربوية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حيث تنمية مهارات التواصل تعتبر عامل أساسي في تحسن حالة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تعتبر المدخل للولوج الى عالم الطفل ذو اضطراب طيف التوحد وبناء علاقة ثقة معه لتمكين الاختصاصي المعالج من بدأ الكفالة والنجاح فيها.

مهارات التواصل والوقوف على الصعوبات التي يعاني منها على هذا المستوى وذلك لأجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الصعوبات أثناء بناء البروتوكول العلاجي، التأهيلي أو التربوي لأن هذا العامل أساسي في نجاح هذه البرامج.

مما سبق تتجلى أهمية دراسة الصعوبات والمشاكل في المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية التي يعاني منها أطفال ذوي من اضطراب طيف التوحد، لأجل ذلك أتت الدراسة الحالية لتقييم مهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية عند الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والوقوف عند الصعوبات التي تعيق عملية التواصل الفعال لديهم والاندماج في المجتمع.

وعليه جاءت تساؤلات الدراسة كما يلي:

التساؤل العام:

ما مستوى مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

التساؤلات الفرعية:

ما مستوى مهارة التواصل البصري لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

ما مستوى مهارة الاهتمام والانتباه المشترك لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

ما مستوى مهارة التقليد لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

ما مستوى مهارة الفهم ل لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

ما مستوى مهارة التعبير لطفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

ولمعالجة هذه التساؤلات والإجابة عليها وضعنا الفرضيات التالية:

الفرضية العامة:

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي.

الفرضيات الجزئية:

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارة التواصل البصري.

يتميز الطفل ذو اضطراب طيف التوحد بمستوى منخفض لمهارة الاهتمام والانتباه المشترك.

الفرعية الخمسة (التواصل البصري، الإنتباه والإهتمام المشترك، التقليد، الفهم، التعبير).
ثالثا- التقييم:

هو مجموعة من الاجراءات المنظمة والتي تهدف الى التعرف على جوانب القوة والضعف لدى الطفل المعاق، وذلك من أجل تحديد احتياجاته التربوية الخاصة، والتعرف على مدى ملائمة البرامج التربوية المقدمة له².
ونعرف التقييم في هذه الدراسة إجرائيا على كونه يتحقق بتطبيق مقياس تقدير المهارات التواصلية اللفظية وغير لفظية على عينة الدراسة.

المحور الثاني: الإجراءات المنهجية:

أولا- المنهج:

لمعالجة فرضيات الدراسة والتحقق منها فإن الباحث يتبع منهج معين بحيث يتفق وطبيعة المشكلة التي يعالجها من جهة، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها من جهة أخرى، ونظر لأن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية لدى اضطراب ذوي طيف التوحد، فإن المنهج المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي الذي يتوافق مع طبيعة متغيرات الدراسة.

ثانيا- حدود الدراسة:

1- الحدود المكانية:

قمنا بالجانب التطبيقي للدراسة على مستوى عيادتين خاصتين، الأولى عيادة الأمل الأرطوفونية للأخصائية: عاشوري أمينة عائشة المتواجدة بحي براكني ولاية البليدة، والثانية العيادة الأرطوفونية للأخصائي الأرطوفوني: هوارى محمد المتواجدة بخميس مليانة ولاية عين الدفلى، حيث تحصلنا على عينة الدراسة من خلال الحالات التي يتم إستقبالهم على مستوى العيادتين.

2- الحدود الزمانية:

يقدر المجال الزمني لهذه الدراسة بحوالي أربعة (4) أشهر بين البحث النظري والتطبيق الميداني، حيث بدأنا التطبيق يوم 2022/10/02 إلى يوم: 2022/12/01، حيث قمنا أولا بتطبيق مقياس تقدير التوحد الطفولي (CARS) لتحديد العينة التي تضم أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (درجة متوسطة) تراوحت اعمارهم ما بين 03 و 06 سنوات، وإستبعاد الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بدرجة خفيفة أو مرتفعة، وبعد إتمام إنتقاء عينة الدراسة، قمنا ثانيا

إن الإلمام بمعرفة الإضطرابات والصعوبات على مستوى مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي التي يعاني منها أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يساعد المختصين في الميدان لتسطير البروتوكول العلاجي الناجح، الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية هذه المهارات لأنها تساهم بشكل كبير في ادماج أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجتمع.

المحور الأول: تحديد المفاهيم الاساسية للدراسة

أولا- مفهوم اضطراب طيف التوحد:

تعددت التعاريف للإضطراب طيف التوحد إبتداء من تعريف ليو كانر الى تعريف إسبرجر الى الدليل التشخيصي الإحصائي للإضطرابات العقلية الإصدار الرابع DSM4 الذي أدرج التوحد تحت مظلة الاضطرابات النمائية الشاملة، ثم صنف الدليل التشخيصي الإحصائي للإضطرابات العقلية الإصدار الخامس DSM5 اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات العصبية

ووفقا لـ (DSM-5) يوجد الآن تشخيص موحد تحت مسمى اضطراب طيف التوحد، حيث أن اضطراب طيف التوحد يضم أربعة إضطرابات وهي: التوحد، اضطراب إسبرجر، اضطراب الطفولة الانحلالي، اضطراب النمو المتعمم غير المحدد بشكل آخر، ويمكن تمييز اضطراب طيف التوحد بعرضين مهمين هما: النقص في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي و كذلك محدودية وتكرار السلوك والاهتمامات والنشاطات.

ونعرف اضطراب طيف التوحد إجرائيا في هذه الدراسة بنقص في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي وظهور السلوكات النمطية بدرجة متوسطة لدى مجموعة من الأطفال بعد تشخيصهم وفق مقياس تقدير التوحد الطفولي (CARS) وتراوحت اعمارهم ما بين 03 و 06 سنوات، والذين ليس لديهم أي اضطرابات أخرى.

ثانيا- مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي:

هي مجموعة من الأنشطة والوسائل والاستراتيجيات التي يكتسبها الفرد لتمكنه من التفاعل مع الآخرين ومشاركهم و زيادة قدرته على التعبير والحركة بفعالية، فهي تعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد تطبيق قائمة لقياس مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى أطفال طيف التوحد، من خلال درجة الأبعاد

بتطبيق مقياس التواصل اللفظي وغير اللفظي على أفراد العينة المكونة من عشرة (10) أفراد.

ثالثا-العينة:

مكونة من عشرة (10) أطفال من ذوي إضطراب طيف التوحد درجة متوسطة، شخوصا من خلال مقياس تقدير التوحد الطفولي (CARS)، منهم ثمانية (08) ذكور وإثنان (02) إناث تراوحت أعمارهم ما بين 03 و 06 سنوات، ولا يعانون من أي اضطرابات مصاحبة، وقد اختيرت العينة بطريقة قصدية والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:

الجدول رقم (01): وصف عينة الدراسة

الرقم	اسم الحالة	الجنس	السن	درجة التوحد
01	ي.م	ذ	3 سنوات	متوسطة
02	ف.ا	ذ	3 سنوات	متوسطة
03	ي.س	ذ	5 سنوات	متوسطة
04	أ.س	ذ	3 سنوات ونصف	متوسطة
05	ج.ج	ذ	3 سنوات	متوسطة
06	ع.ز	أ	3 سنوات	متوسطة
07	ح.إ	ذ	5 سنوات	متوسطة
08	ب.إ	ذ	5 سنوات ونصف	متوسطة
09	س.م	أ	5 سنوات ونصف	متوسطة
10	ح.ي	ذ	6 سنوات	متوسطة

رابعا-أدوات الدراسة: تم الاعتماد في هذه الدراسة على الأدوات التالية

1- مقياس تقدير التوحد الطفولي Echelle d'évaluation de l'autisme infantile (CARS)

تم تأليفه من طرف العالم شوبلر ورفاقه عام (1988) وهو يقيم خمسة عشر (15) جانبا لدى الطفل وهي كالتالي: الانتماء للناس- التقليد والمحاكاة- الاستجابة الانفعالية - استخدام الجسد، استخدام الأشياء- التكيف المتغير - الاستجابة البصرية -الاستجابة السمعية- استجابة واستخدام التذوق والشم واللمس- الخوف او القلق، التواصل اللفظي- التواصل غير اللفظي-مستوى النشاط- مستوى وثبات الاستجابة العقلية -الانطباعات العامة، حيث المقياس موجه الى الأطفال الذين أعمارهم فوق

العامين(02)، ويقاس كل جانب من هذه الجوانب الخمسة عشر للمقياس مدى انحراف سلوك الطفل عن سلوك الطفل العادي.

يتم إعطاء الدرجات من (1-4) حسب شدة الصفة عند الطفل، نقوم بجمع العلامات في الأخير لتعبر عن الدرجة النهائية، حيث تعبر الدرجة أقل من(30) الى عدم وجود اضطراب عند الطفل، و الدرجة ما بين (30) و (36) تشير الى وجود الإضطراب بدرجة بسيطة إلى متوسطة، أما الدرجة الأكبر من (36) تشير الى وجود اضطراب شديد، حيث يستغرق تطبيق المقياس من 30 إلى 45 دقيقة .

2- مقياس التواصل اللفظي وغير اللفظي:

أعد المقياس من طرف الباحثة إبتسام الحسني لمقياس مهارات التواصل اللفظي وغير لفظي لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذي إحتوى على خمسين (50) بنداً موزعة على خمسة (5) أبعاد هي:

● **بعد التواصل البصري:** يتكون البعد الأول من عشرة(10) بنود مرتبة من 1 إلى 10 تتمحور حول الإستجابات البصرية للطفل.

● **بعد الانتباه والاهتمام المشترك:** يضم البعد الثاني عشرة(10) مرتبة من 11 إلى 20 تدور حول إنتباه الطفل واهتمامه بما حوله من أشياء وأشخاص وتفاعله معهم.

● **بعد التقليد:** يحتوي البعد الثالث على عشرة(10) بنود مرتبة من 21 إلى 30 تتمحور حول تقليد الطفل للحركات وتكراره للأصوات³.

● **بعد الفهم:** البعد الرابع يحتوي كذلك على عشرة(10) بنود مرتبة من 31 إلى 40، موزعة حول ثلاث محاور هي: فهم إيماءات الوجه وحركات الجسد، التعرف على أجزاء الجسم وعلى الأشياء اليومية والإستجابة للأوامر وتنفيذها.

● **بعد التعبير:** يتكون هذا البعد الأخير كذلك من 10 بنود مرتبة من البند 41 إلى البند رقم 50 موزعة على ثلاث محاور هي: استخدام الطفل للإشارة، استخدامه للإيماءات الوجهية والحركات الجسدية والتعبير الشفهي.

يتم الإجابة على بنود القائمة من قبل أحد أولياء.

*مفتاح التصحيح:

تعطى الدرجات من 1 الى 5 على النحو التالي:

دائما= 5 ، غالبا = 4، أحيانا= 3، نادرا= 2، أبدا= 1.

*معايير المقياس:

الثاني ، وتحصلت على معامل الارتباط بيرسون يساوي $r=0.946$ ، وهو معامل ثبات عال جدا ودال إحصائيا، أي أن نتائج درجات القياس القبلي والبعدي للمقياس مستقرة عبر الزمن وثابتة، ومنه يمكن اعتماد هذا المقياس في دراستنا الحالية.

المحور الثالث: عرض ومناقشة النتائج :

أولا- النتائج:

قمنا بتطبيق مقياس تقييم مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي على عينة الدراسة وتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول الآتي:

الجدول رقم (02): نتائج أفراد العينة

أظهرت المعطيات التحصل عليها في الجدول أعلاه نتائج

الدرجة الكلية للمقياس	التعبير	الفهم	التقليد	الانتباه والإهتمام المشترك	التواصل البصري	المحاور الحالات
107	29	19	21	21	17	ي.م
115	25	19	22	26	23	ف.أ
115	21	23	20	28	23	ي.س
100	21	18	18	19	14	أ.س
124	24	26	25	26	23	ع.ر
125	19	19	23	28	26	ع.ز
104	17	21	18	27	21	ح.إ
127	25	26	26	25	25	ب.إ
127	27	26	26	25	25	س.م
129	29	25	29	23	23	ح.ي

تطبيق مقياس تقييم مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي على عينة مكونة من عشرة (10) أفراد مصابين باضطراب طيف التوحد ، واشتملت النتائج على درجة الأبعاد الخمسة (05) للمقياس والتي تمثل المهارات الأساسية للتواصل اللفظي وغير لفظي وهي :التواصل البصري، الانتباه والاهتمام

بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي:

الدرجة 50 من 125 درجة تعبر عن مستوى منخفض.

الدرجة 126 من 150 درجة تعبر عن مستوى متوسط.

الدرجة 151 من 175 درجة تعبر عن مستوى مرتفع.

بالنسبة للأبعاد الخمسة للمقياس: التواصل البصري، الانتباه والاهتمام المشترك، التقليد، الفهم والتعبير:

الدرجة 10 من 25 درجة تعبر عن مستوى منخفض.

الدرجة 26 من 30 درجة تعبر عن مستوى متوسط.

الدرجة 31 من 35 درجة تعبر عن مستوى مرتفع.

الخصائص السيكومترية للأداة:

تأكدت الباحثة من الخصائص السيكومترية للأداة (الصدق، الثبات) كالآتي:

صدق القائمة:

أ.الصدق الظاهري: قامت الباحثة بتعديل بعض البنود وذلك بعد عرض المقياس على مجموعة من المحكمين، ليتم بذلك صياغة المقياس بصورتها النهائية، وبعد ذلك قامت بعرض الصورة النهائية للمقياس مرة أخرى على نفس المحكمين، حيث تم قبول الأداة وتأكيد على دقتها وملاءمة بنودها لقياس السمة التي صمم المقياس لأجله، وهذا ما يؤكد صدق الأداة.

ب.صدق المحتوى: أظهرت القيم المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين إلى نسبة إتفاق تساوي 93.2% ، وبعد تطبيق معادلة لوشي كانت درجة ص م $=0.86$ أي أنها >0.50 وهو معامل جيد ويؤكد أن البنود الموضوعة صادقة في قياسها وأن المقياس المقترح صالح لقياس ما أعد له.

ثبات القائمة:

أ.الاتساق الداخلي:

للتحقق من الاتساق الداخلي لبنود المقياس تم حساب معامل ألفا كرومباخ من طرف الباحثة، حيث تراوحت معاملات ألفا لكرومباخ ما بين 0.764 و 0.874 ،

وهو ما يثبت مدى تجانس وقوة الاتساق الداخلي للقائمة وبالتالي يمكن اعتبار بنود المقياس متسقة ومرتبطة ببعضها البعض ويمكن الإعتماد عليها.

ب. التطبيق وإعادة التطبيق: بعد قيام الباحثة بحساب معامل الارتباط بيرسون بين درجات التطبيق الأول والتطبيق

المشترك، التقليد، الفهم، التعبير، والدرجة الكلية للمقياس، حيث كانت النتائج كما يلي:

بالنسبة لمهارة التواصل البصري: أظهرت النتائج أن أفراد العينة تحصلوا على درجات تراوحت ما بين 17 و 26 درجة من 50 درجة، حيث تحسّلت الحالة (أ.س) درجة 17 وهي أقل درجة، بينما تحسّلت الحالة (ع.ز) على أعلى درجة والمقدرة بـ 26 درجة، كما لاحظنا أن 90 % من الحالات كانت نتائجهم منخفضة .

بالنسبة لمهارة الانتباه والاهتمام المشترك: تراوحت درجات أفراد العينة بالنسبة لبعد الانتباه والاهتمام المشترك ما بين 19 درجة كأدنى درجة والتي حققتها الحالة (أ.س) و 28 درجة كأعلى درجة بالنسبة للحالتين (ي.س) و (ع.ز).

بالنسبة لمهارة التقليد: تحسّلت أفراد العينة في هذا البعد على درجات تراوحت ما بين 18 درجة و 29 درجة كأقصى حد، حيث سجلت الحالة (أ.س) أدنى درجة المقدرة بـ 18 درجة والحالة (ح.ي) أعلى درجة المقدرة بـ 29 درجة من 50 درجة، كما سجلت 70 % من الحالات درجات منخفضة أي مستوى منخفض للمهارة، أما 30% من الحالات تحصلوا على درجات متوسطة أي مستوى متوسط للمهارة.

بالنسبة لمهارة الفهم: تراوحت درجات الحالات بالنسبة لهذه المهارة ما بين 18 درجة كأدنى حد والتي تحسّلت عليها الحالة (أ.س) وهي الحالة المتحصلة على أدنى درجة في مهارة التواصل البصري، الانتباه والاهتمام المشترك ومهارة التقليد، و 26 درجة كأقصى حد والتي تحسّلت عليها الحالة (س.م)، الحالة (ع.ر) والحالة (ب.إ)، كما أن 70 % من أفراد العينة تحصلوا منها على درجات تراوحت ما بين 18 و 25 درجة وهي درجات منخفضة تعبر عن مستوى منخفض للمهارة، بينما تحسّلت 30 % منها على درجة 26 من 50 درجة وهي درجات متوسطة .

بالنسبة لمهارة التعبير: نلاحظ أن درجات أفراد العينة تراوحت ما بين 17 درجة بالنسبة للحالة (ح.إ) كأدنى درجة و 29 درجة بالنسبة للحالتين (ع.ز) و (ح.ي) كأعلى درجة وهذه الأخيرة متحصلة على أعلى درجة في مهارة التقليد كذلك، بالنسبة لـ 60% من الحالات تحصلوا على درجات ما بين 17 درجة و 25 درجة أي درجات منخفضة و 40 % من الحالات تحسّلت على درجات ما بين 27 و 29 درجة من 50 درجة أي درجات متوسطة.

بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس تقييم مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي: تحسّلت 70 % من الحالات على درجات منخفضة وهي تتراوح ما بين 100 و 125 درجة وهي تعبر عن مستوى منخفض لمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، أما 30% من الحالات تراوحت درجاتهم ما بين 127 درجة و 129 درجة من 250 درجة، وهي درجات متوسطة تعبر عن مستوى متوسط، حيث سجلت أدنى درجة عند الحالة (أ.س) المقدرة بـ 100 درجة وهي الحالة المتحصلة على أدنى درجة في كل من مهارة (التواصل البصري، الانتباه والاهتمام المشترك، التقليد والفهم)، وأعلى درجة عند الحالتين (س.م) و (ح.ي) والمقدرة بـ 129 درجة من 250 درجة، حيث الحالة (س.م) متحصلة على أعلى درجة في مهارة الفهم والحالة (ح.ي) ومتحصلة على أعلى درجة في كل من مهارة التقليد والتعبير .

نلاحظ عموماً بعد عرض النتائج أن درجات أبعاد القائمة والدرجة الكلية لعينة الدراسة منخفضة حسب تصحيح المقياس حيث كلما زادت درجات المقياس كان التواصل مرتفع وكلما انخفضت الدرجات كان التواصل ضعيف، وبما أن الدرجات منخفضة فهذا يدل على ضعف في المهارات الأساسية للتواصل اللفظي وغير اللفظي عند مجمل أطفال العينة، وكذلك عدم تحكم أفراد العينة في المهارات التواصلية اللفظية وغير اللفظية (التواصل البصري، الانتباه والاهتمام المشترك، التقليد، الفهم والتعبير) وذلك رغم تفاوت الدرجات.

ثانياً- مناقشة النتائج:

بينت نتائج الدراسة تحقق الفرضية العامة، حيث أثبتت فعلاً أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتميزون بمستوى منخفض لمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لأغلب حالات الدراسة، حيث توافقت في صعوبات الجانب غير اللفظي مع دراسة⁴ (Vitaskova & Rihova, 2013) التي اهتمت بدراسة تحليل أشكال ضعف التواصل غير اللفظي عند الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من قصور في التقليد، التتبع، انخفاض في إنتاج وإدراك الإيماءات، إدراك الوجه، ونقص في التواصل أثناء التعبير الجسدي، وطلب الأشياء، وكذا نقص في الاهتمام بالآخرين.

على درجات مرتفعة بسلوك مسك يد الشخص لما يريدونه مقارنة بالأطفال المصابين بإعاقات نمائية أخرى.

كما وضح روتر (Rutter, 1983) أنه مع نهاية السنة الأولى من العمر يظهر الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد بعض الشذوذ في الإتصال بالعندين، و سلوك الحملقة بالعين من أهم الصعوبات الشائعة لدى الأطفال التوحديين.

على مستوى مهارة الإنتباه والإهتمام المشترك فتوافقت الدراسة الحالية مع ما أثبتته العديد من الدراسات (Bacon, 1998) ⁸ Fein, Morris, Waterhouse, & Allen, 1998) لصعوبات في الانتباه المشترك لدى الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مقارنة بالأطفال ذوي التأخر النمائي أو ذوي النمو الطبيعي.

كما يساند ذلك (Eissa, 2015) الذي يذكر أن القصور في مهارة الإنتباه والإهتمام المشترك لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تظهر منذ سن مبكرة، بينما الطفل العادي يتمكن من اكتسابها ابتداء من (06) أشهر من عمره، حيث تظهر على شكل القدرة على مشاركة الاهتمام و الإنتباه عن طريق نظرات العين، اتباع نظرات الآخرين أو الإشارة وتوجيه انتباه الآخرين عن طريق نظرات العين أو الإشارة.

أظهرت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود صعوبات في مهارة التقليد لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وتميزها

بمستوى منخفض عموماً، وهذا ما توافق مع دراسة (Vanvuchelen, Roeyers, & De Weerd, 2011) ⁹ التي

أشارت نتائجها إلى صعوبة أداء المهمات المتعلقة بالتقليد: الإشارات وتعابير الوجه، التقليد باستعمال الجسد، والتقليد باستعمال الأشياء لدى أطفال اضطراب طيف التوحد.

بالنسبة لبعدها الفهم الذي يضم فهم إيماءات الوجه وحركات الجسد، التعرف على أجزاء الجسم وعلى الأشياء اليومية والإستجابة للأوامر وتنفيذها، توصلت الدراسة الحالية إلى وجود ضعف على مستوى هذه المهارات وهذا ما أثبتته دراسة ليبست وآخرون (Lepist, shestaKova, 2003) ¹⁰ Vanhala, Alku, Nktnen, & Yaguchi, التي أشارت إلى عجز أطفال التوحد في تمييز نغمات الصوت وما حدث لها من تغيير وقد أرجع الباحثون هذا العجز إلى القصور في مهارة الانتباه والاستماع لديهم وإلى عجزهم عن فهم الأوامر.

أظهرت نتائج الدراسة أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد "درجة متوسطة" يعانون من عجز وقصور على مستوى مهارات التعبير، وهذا ما يتفق مع ذكره (Jordan,

أيد ماسبق في هذا الجانب كل من (Field, Nadel, & Ezell, 2011) ⁵ في دراستهم التي توصلت إلى أن قدرات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد غير اللفظية تكون إما عاجزة، أو بطيئة في المبادرة لتقليد الآخرين بحيث يؤثر هذا القصور في التفاعل الاجتماعي وتنمية المهارات اللغوية.

كما تتوافقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة شيخي مبروك و بوطغان محمد الطاهر (2019) ⁶ التي توصلت نتائجها إلى أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم قصور واضح في مهارات التواصل غير اللفظي التالية: الانتباه المشترك، التواصل البصري، التقليد، الاستماع والفهم، الإشارة إلى ما هو مرغوب فيه.

أما فيما يخص جانب اضطراب التواصل اللفظي لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فتوصلت الدراسة الحالية إلى وجود مستوى منخفض لمهارات هذا الجانب عند جميع أفراد العينة وهذا ما أيدته العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن ما نسبة 50 % من أطفال طيف التوحد لا تتطور لديهم قدرات لغوية تعبيرية حيث يعتبرون بأنهم صامتون أو غير ناطقين، ويعوضون اللغة المنطوقة بالإيماءات المباشرة مثل: سحب يد البالغ لما يريد فهو يستخدمه كأداة،

توصلت الدراسة الحالية إلى تحقق الفرضيات الجزئية الخمسة للدراسة التي جاء فيها أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتميزون بمستوى منخفض في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي وفي أبعاده (التواصل البصري-الاهتمام والإنتباه المشترك-التقليد-الفهم-التعبير)، حيث تبين من نتائج الدراسة أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتميزون بمستوى منخفض لمهارات الأساسية للتواصل اللفظي وغير لفظي والمتمثلة في الأبعاد الخمسة للمقياس المستعمل في الدراسة الحالية وهي كالتالي.

بالنسبة لمهارة التواصل البصري توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى أن جل حالات العينة تميزت بتواصل بصري منخفض وهذا ما يتطابق مع ما أشارت إليه دراسة ستون وزملاؤه (Stone, Ousley, Yoder, Hogan, & Hepburn, 1997) ⁷ التي توصلت إلى أن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تحصلوا على درجات منخفضة في مهارة الإشارة إلى ما هو مرغوب فيه، التحديق بالعين والحركات الإيمائية مقارنة بالأطفال المصابين بإعاقات نمائية أخرى، في حين تحصلوا

دراسات تقف عند طبيعة العجز وقصور في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي وإرتباطها بالمشاكل السلوكية عند هذه الفئة.

كما نوصي القائمين على هذه الفئة الاهتمام أكثر بتطبيق النتائج المتوصل إليها في البحوث العلمية خاصة البرامج التأهيلية وعلاجية التي تم التحقق من فعاليتها.

كذلك نوصي بإجراء اتفاقية بين الجامعة والمؤسسات التي تتكفل بأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك لتسهيل عمل الباحثين وأجراء البحوث وكذلك العمل على تطبيق نتائج البحوث المتوصل على مستوى هذه المؤسسات خاصة البرامج التأهيلية والعلاجية.

قائمة المراجع:

• الكتب:

اموندا بوتو: اضطرابات طيف التوحد- الأسس، والخصائص، والإستراتيجيات الفاعلة، (محمد الحياوي غالب، المترجمون) دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، 2018.

فوزية بنت عبد الله الجلامدة: قياس وتشخيص اضطرابات طيف التوحد، (ط2)، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 2016،

Jordan, R. R: The nature of the linguistic and communication difficulties of children with autism. N: Critical influences on child language acquisition and development , D. J. Messer and G. J. Turner. New York, NY: St Martins Press, 1993.

المقالات:

مبروك شيخي، و محمد الطاهر بوطغان: تقييم مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال التوحد. مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، 10 (1)، 2019.

Bacon, A., Fein, D., Morris, R., Waterhouse, J. L., & Allen, D: The responses of autistic children to the distress of others. Journal of Autism Developmental Disorders, 28 (2), 1998 , 129-142.

Field, T., Nadel, J., & Ezell, S: Imitation Therapy for Young Children with Autism. Autism Spectrum Disorders, From Genes to Environment, 2011 . 287-297.

Lepist, T., shestaKova, Vanhala, Alku, P., Nktnen, R., & Yaguchi, K: Speech sound- selection auditory impairment in children with autism: they can perceive but do not attend, Proceeding of the National Academy of Science of The United States of America , 27 (6), 2003, 5567-5573.

Stone, L., Ousley, O., Yoder, J., Hogan, L., & Hepburn, L: Non verbal communication in two and three -year- children with Autism, Journal of Autism and Developmental Disorders , 27 (6), 1997, 677-696.

1993) بأن الاطفال التوحدين منهم من لا يستطيع الحديث، ومنهم من يتأخر في تطوير تلك المهارة، وهذا يشير إلى ان اضطراب التوحد يؤثر على كل أنماط السلوك التواصلية للطفل منذ المراحل الأولى.

خاتمة:

يعد اضطراب طيف التوحد من الإضطرابات النمائية العصبية الذي يمس ثلاثة جوانب عند الطفل هي: التواصل، المهارات الإجتماعية، التخيل، حيث يمكن تشخيصه من خلال الاعراض السلوكية المميزة المتمثلة في: القصور في التواصل الإجتماعي ومهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية وكذلك السلوكات النمطية، كما أن المهارات التواصلية عند أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تختلف تماما عن ما هو عند الطفل السوي فهي تتميز بالقصور على المستوى اللفظي وغير اللفظي، وهذا ما توصلت إليه الدراسة الحالية، حيث أظهرت أن أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يتميزون بمستوى منخفض لهذه المهارات ويظهرون عجز واضح على مستوى (التواصل البصري، الانتباه والاهتمام المشترك، التقليد، الفهم والتعبير)، ولأهمية مهارات التواصل في دمج أطفال طيف التوحد في المجتمع، فمن الضروري على المختصين والعاملين في هذا المجال التركيز على تنمية مهارات التواصل لدى هذه الفئة أثناء بناء الخطة الفردية العلاجية وكذا البرامج التأهيلية.

إن مهارات التواصل خاصة مميزة ومشخصة بالنسبة لأطفال اضطراب طيف التوحد، لذا يجب أن تحظى بدراسات معمقة، وفي ضوء النتائج المتوصل إليها نقترح بحوث أخرى تتمثل فيما يلي:

دراسات لمعرفة مستوى مهارات التواصل عند فئات أخرى من أطفال اضطراب طيف التوحد (الخفيف، الشديد).

دراسات للتحقق من فعالية البرامج التأهيلية لتحسين مهارات التواصل عند اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

دراسات حول استخدام تكنولوجيا الاعلام الآلي في تطوير برامج تأهيلية وعلاجية لتحسين مهارات التواصل عند اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

انجاز بحوث مماثلة للدراسة الحالية مع فئات عمرية أخرى لم تشملها الدراسة الحالية وكذلك توسيع العينة لنتمكن من تعميم النتائج.

Disorders, From Genes to Environment, 2011 . 287-297.

⁶ميروك شيخي، و محمد الطاهر بوطغان:تقييم مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال التوحد.مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية ، 10 (1)، 2019، ص171.

⁷ Stone, L., Ousley, O., Yoder, J., Hogan, L., & Hepburn, L :Non verbal communication in two and three –year- children with Autism, Journal of Autism and Developmental Disorders , 27 (6), 1997, 677-696.

⁸Bacon, A., Fein, D., Morris, R., Waterhouse, ., L., & Allen, D :The responses of autistic children to the distress of others. Journal of Autism Developmental Disorders, 28 (2), 1998 , 129-142.

⁹Vanvuchelen, M., Roeyers, H., & De Weerdt, W. (2011). Development and initial validation of the Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS), Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 2011, 463-473.

¹⁰Lepist, T., shestaKova, Vanhala, Alku, P., Nktnen, R., & Yaguchi, K: Speech sound- selection auditory impairment in children with autism: they can perceive but do not attend, Proceeding of the National Academy of Science of The United States of America , 27 (6), 2003,5567-5573.

Vanvuchelen, M., Roeyers, H., & De Weerdt, W. (2011). Development and initial validation of the Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS), Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 2011, 463-473.

Vitaskova, K., & Rihova:AAanalysis of impaired nonverbal communication in people with autism spectrum disorder, SOCIAL WELFARE INTERDISCIPLINARY APPROACH,3(2) ,2013 .

الاطروحات:

إبتسام الحسني: الوظائف المعرفية التنفيذية وعلاقتها بالقدرة التواصلية عند الطفل المصاب بالتوحد ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الأوطوفونيا، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة ابو القاسم سعد الله الجزائر 2، 2020.

الهوامش:

¹اموندا بوتو:إضطرابات طيف التوحد-الأسس، والخصائص، والإستراتيجيات الفاعلة،(محمد الحياوي غالب، المترجمون) دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، 2018، ص 28.

²فوزية بنت عبد الله الجلامدة:قياس وتشخيص إضطرابات طيف التوحد،(ط2)، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 2016، ص33.

³إبتسام الحسني: الوظائف المعرفية التنفيذية وعلاقتها بالقدرة التواصلية عند الطفل المصاب بالتوحد ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الأوطوفونيا، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة ابو القاسم سعد الله الجزائر 2، 2020، ص167-168.

⁴ Vitaskova, K., & Rihova:AAanalysis of impaired nonverbal communication in people with autism spectrum disorder, SOCIAL WELFARE INTERDISCIPLINARY APPROACH,3(2) ,2013,3(2), 87-97 .

⁵Field, T., Nadel, J., & Ezell, S: Imitation Therapy for Young Children with Autism. AutismSpectrum